

«Внутрішньокістковий доступ»

Сценарій

Ви працюєте лікарем бригади ЕМД. Вас викликали на місце ДТП. Постраждалий 25 років збитий автомобілем, знаходиться на землі, при свідомості. При первинному огляді виявлена травматична деформація лівої нижньої кінцівки, зовнішня кровотеча у верхній 1/3 стегна. Для знеболення, проведення інфузійної терапії та підготовки до можливої госпіталізації необхідно встановити лінію інфузії. Постраждалий страждає на наркоманію, встановити периферичний венозний доступ не можливо. Необхідний альтернативний вид доступу, встановлення внутрішньокісткового доступу.

Скарги: Пацієнт скаржиться на сильний біль у ділянці переломів, спрагу, слабкість, запаморочення.

Анамнез захворювання: Біль з'явився внаслідок ДТП, постраждалий збитий автомобілем. Хронічні захворювання не відмічає, страждає на наркоманію протягом 5 років, ін'єкційна форма.

Анамнез життя: Алергії: не виявлено. Хірургічні втручання: апендектомія у 17 років.
Об'єктивно: Загальний стан: вкрай важкий. Пацієнт неспокійний через біль. Шкірні покриви: бліді. АТ: 70/50 мм рт. ст.. ЧСС: 124/хв, ЧД: 22/хв. Живіт: безболісний, м'який, периферичні вени не візуалізуються.

Додатково:

Встановити внутрішньокістковий доступ. Провести знеболення, почати інфузію.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує вулицю, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Хірургічний лоток	2 шт.
2	Контейнер для утилізації	1 шт.
3	Медичні ножиці	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кіл-ть на 1 спробу	Кількість на 10 спроб
1	Марлеві кульки для обробки шкіри	2 шт	20 шт
2	Антисептичний розчин (70% розчин етилового спирту)	10 мл	100 мл
3	Медичні стерильні рукавички	1 пара	10 пар
4	Лейкопластир	1 шт	10 шт
5	Захисна медична маска	1 шт	10 шт
6	Стерильна марля (наприклад, квадрати 10 см × 10 см)	1 шт	10 шт
7	Внутрішньокісткові голки та іноді пристрій для введення	1 шт	10 шт
8	Шприци, від 5 до 60 мл, залежно від передбачуваної потреби	1 шт	10 шт
9	Стерильний фізіологічний розчин для промивання	1 шт	10 шт
10	Внутрішньовенні з'єднувальні трубки та рідини	1 шт	10 шт
11	Місцевий анестетик (1% лідокаїн без адреналіну, голка 25-го або 22-го калібру, шприц 3- або 5 мл)	1 шт	10 шт



ВНУТРІШНЬОКІСТКОВІ ГОЛКИ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ



ВНУТРІШНЬОВЕННА З'ЄДНУВАЛЬНА ТРУБКА

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітатися з пацієнтом або командою, представитися, назвати свою роль. Провести швидкий огляд постраждалого. Пояснити необхідність встановлення внутрішньокісткового доступу, за можливості — отримати згоду	Сказати <i>Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я).</i> Сказати/Виконати
1.2	Виконати гігієнічну обробку рук, одягнути рукавички	Виконати/ Сказати <i>Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2.Виконання навички		
2.1	Попередньо промийте всі внутрішньовенні лінії та з'єднувальні трубки фізіологічним розчином.	Сказати/ Виконати
2.2	Підготуйте шприц з 5-10 мл стерильного фізіологічного розчину.	Виконати
2.3	Визначити місце пункції	Сказати: <i>Дистальний відділ великогомілкової кістки є кращим місцем для ручного введення. Голку вводять на медіальній поверхні великогомілкової кістки на стику медіальної кісточки та діафіза великогомілкової кістки, позаду великої підшкірної вени</i>
2.4	Провести місцеву анестезію	Сказати: <i>Для анестезії місця введення наберіть 3-5 мл 1% лідокаїну/Виконати</i>
2.5	Протріть ділянку шкіри навколо місця канюляції антисептичним розчином	Сказати/ Виконати
2.6	Провести внутрішньокісткове (ВК) введення голки	Сказати: <i>Голку вводять з помірним тиском та обертальним рухом, який зупиняється, як тільки почуєте клацання, що вказує на проникнення кортикального шару. Деякі голки мають пластиковий чохол, який можна регулювати, щоб запобігти їх занадто глибокому введенню в кістку або крізь неї./Виконати</i>
2.7	Підтвердіть внутрішньомозкове розташування голки. Почніть внутрішньомозкову інфузію	Сказати/Виконати
2.8	Накладіть пов'язку на місце інфузії Утилізувати використані матеріали, зняти рукавички, обробити руки	Сказати/Виконати
3. Встановити попередній діагноз(визначити стан пацієнта)		

3.1	Травматичний шок, гіповолемія	<i>Сказати</i>
-----	-------------------------------	----------------

4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Після встановлення внутрішньокісткового доступу перевірити функціонування катетера, наявність відтоку крові, відсутність підшкірного введення інфузійного розчину. Налагодити внутрішньокісткову інфузію кристалоїдів, спостерігати за гемодинамічними показниками, доставити постраждалого до стаціонару.	Сказати